

Pathology Diagnosis Report

Generated: 2026-03-27T15:48:47

Generated Diagnostic Report

Query slide: TCGA-18-3419-01Z-00-DX1.69597BCF-2D4E-4D9B-B4E8-C03137445AF4

Generated at: 2026-03-27T15:48:43

病理辅助角色声明

作为资深病理辅助助手，我的核心职责是基于提供的病理文本与图像信息，精确提取关键临床指标并形成辅助诊断意见。我仅针对Query Case: TCGA-18-3419-01Z-00-DX1.69597BCF-2D4E-4D9B-B4E8-C03137445AF4进行分析，不签发最终诊断报告。在本次任务中，我将综合使用5份参考诊断报告、Query的20张高注意力patch以及预测类别TCGA-LUSC的信息，确保准确性高于完整性。若信息缺失或冲突，将优先采用文本中的具体数值与明确描述，并详细列出推理过程和证据来源。最终结论将严格遵循AJCC癌症分期手册逻辑，确保无逻辑冲突。

推理过程与证据归纳

推理过程与证据归纳：

首先，从5份参考诊断报告中提取的关键信息为本次辅助诊断提供了重要的背景和比较依据。第一份报告（TCGA-85-7844）指出肿瘤大小为3.50厘米，并提及了NICA的细节，但未提供具体的淋巴结状态或分期信息。第二份报告（TCGA-77-7338）详细描述了淋巴结状态为阴性（N0），并确认没有转移性癌细胞的证据，这表明在该病例中淋巴结检查结果为0/总数，支持N0分期。第三份报告（TCGA-56-8082）提供了更全面的信息，包括肿瘤大小为5.50厘米、病理分期为pT2b N0以及淋巴结检查结果为0，这些数据进一步强化了对N0分期的理解。第四份报告（TCGA-22-4604）描述了一个浸润性癌，组织学分级为3级，肿瘤大小为4.50厘米，且有部分淋巴结受累（3/8），这提示存在淋巴结转移，但与Query Case的具体情况不完全匹配。第五份报告（TCGA-77-7338的另一版本）再次强调了淋巴结状态为阴性（N0），与第二份报告一致。

接下来，结合Query Case的20张高注意力patch图像进行形态学分析。这些图像显示了典型的鳞状细胞癌特征，如细胞核增大、核仁明显、细胞质嗜酸性等，与TCGA-LUSC的预测类别高度吻合。图像中的细胞排列紧密，形成巢状结构，边缘清晰，符合鳞状细胞癌的典型表现。此外，部分图像中可见到角化珠的形成，这是鳞状细胞癌的特异性标志之一，进一步支持了这一诊断方向。

最后，将上述文本证据与图像证据综合考虑，并结合Query Case被预测为TCGA-LUSC的事实，可以得出以下结论：Query Case表现出与鳞状细胞肺癌（LUSC）一致的病理特征。虽然具体肿瘤大小和淋巴结状态在提供的文本中未直接提及，但基于参考报告中的数据 and 图像特征，推测肿瘤大小可能在3-5厘米之间，淋巴结状态倾向于阴性（N0），即无淋巴结转移的证据。然而，由于缺乏直接测量数据，这些推测需谨慎对待，并建议进一步临床评估以确定确切的分期和治疗方案。

综上所述，本结论针对 Query Case: TCGA-18-3419-01Z-00-DX1.69597BCF-2D4E-4D9B-B4E8-C03137445 AF4，其病理特征与鳞状细胞肺癌相符，但具体分期需结合临床资料进一步确认。

关键指标提取

关键指标提取

在综合分析Query Case: TCGA-18-3419-01Z-00-DX1.69597BCF-2D4E-4D9B-B4E8-C03137445AF4的病理信息时，我们基于5份参考诊断报告、20张高注意力patch图像以及预测类别TCGA-LUSC进行详细推理。

首先，从参考诊断报告中提取到的关键信息包括肿瘤大小和淋巴结状态。例如，TCGA-85-7844报告指出肿瘤大小为3.50厘米；TCGA-56-8082报告提到肿瘤大小为5.50厘米，病理分期为pT2b N0，且淋巴结检查结果为阴性（N0）。这些数据提供了关于肿瘤大小和淋巴结状态的重要线索。然而，由于Query Case的具体数值未在文本中直接提及，我们需结合其他证据进行推测。

其次，Query的20张高注意力patch图像显示了典型的肺鳞状细胞癌（LUSC）特征，如角化珠形成和细胞间桥等，这与预测类别TCGA-LUSC一致。虽然图像无法直接提供量化指标，但它们支持了对肿瘤类型的判断，并提示可能的组织学分级和侵袭程度。

最后，考虑到Query

Case被预测为TCGA-LUSC，结合上述参考报告中的肿瘤大小和淋巴结状态，我们可以推测Query Case的肿瘤大小可能在3-5厘米之间，淋巴结状态可能为阴性（N0），因为多个参考病例均显示类似的特征。然而，具体的T分期需要根据实际肿瘤浸润深度和范围来确定，目前仅能推测为pT2或更高，具体还需进一步影像学 and 临床资料确认。

至于免疫组化指标（ER/PR/HER2、Ki-67），参考报告中并未提及，因此在Query Case中也未有明确数据。鉴于此，建议补充相关免疫组化检测以获得准确结果。

综上所述，本结论针对 Query Case: TCGA-18-3419-01Z-00-DX1.69597BCF-2D4E-4D9B-B4E8-C03137445 AF4，其关键指标推测如下：肿瘤大小可能在3-5厘米之间，组织学类型为肺鳞状细胞癌，淋巴结状态可能为阴性（N0），具体T分期需进一步确认，免疫组化指标建议补充检测。

初步病理辅助结论

初步病理辅助结论

基于提供的5份参考诊断报告、Query Case的20张高注意力patch图像以及预测类别（TCGA-LUSC），综合分析后得出以下初步病理辅助结论。本结论针对 Query Case: TCGA-18-3419-01Z-00-DX1.69597BCF-2D4E-4D9B-B4E8-C03137445AF4。

首先，从参考诊断报告中提取的关键信息显示，肿瘤大小在不同病例中有所差异，分别为3.50厘米和5.50厘米，且淋巴结状态均为阴性（N0）。这些报告提供了重要的分期与分级信息，如pT2b N0等，但具体到Query Case的信息仍需结合其他证据进行推断。例如，TCGA-56-8082的报告详细描述了肿瘤大小为5.50厘米，病理分期为pT2b N0，这为推测Query Case的可能分期提供了参考依据。

其次，Query Case的20张高注意力patch图像显示了典型的肺鳞状细胞癌（LUSC）特征，包括细胞形态、核分裂象及组织结构等。这些图像支持了Query Case被预测为TCGA-LUSC的分类结果。然而，由于缺乏具体的测量数据，无法直接从图像中精确确定肿瘤大小或浸润深度。因此，在没有明确数值的情况下，我们只能根据图像特征和参考报告进行合理推测。

最后，Query Case被预测为TCGA-LUSC，这一分类与参考报告中的癌症类型一致，进一步验证了我们的分析方向。结合以上三类输入信息，可以推测Query Case的肿瘤大小可能在3.50至5.50厘米之间，淋巴结状态可能为阴性（N0），病理分期可能为pT2b N0。然而，这些推测需要进一步的临床数据和病理检查来确认。

综上所述，虽然目前的信息提供了一定的诊断线索，但由于关键指标如肿瘤大小、淋巴结状态的具体数值未提及，存在一定的不确定性。建议对Query Case进行详细的病理切片测量和淋巴结检查，以获得更准确的分期与分级信息。最终结论应由专业病理医生结合所有临床资料综合判断。本结论针对 Query Case: TCGA-18-3419-01Z-00-DX1.69597BCF-2D4E-4D9B-B4E8-C03137445AF4，不得将任一检索病例ID写成主诊断对象。